

10. 기억력 저하

- **중요 포인트**
 - 1. 기억력 저하를 호소하는 사람에서 인지기능의 평가와 감별진단 및 치료를 시행
 - 2. 보호자가 동반할 수도 있음
 - 3. 보호자 또는 같이 사는 사람들에게도 교육을 해야함

- **평가 목표**

원인			
주관적 기억력 저하		정상노화	
경도인지장애			
일차성 치매		알츠하이머 치매	
이차성 치매		뇌혈관, 파킨슨병, 알코올 등	
심인성 기억저하		가성치매(우울장애), 해리성 기억상실 등	
평가목표			
1) 기억력 장애를 호소하는 환자의 인지기능을 객관적으로 평가			
2) 기억력이 저하되는 대표적 질환을 감별하며, 진단 및 치료 계획을 수립할 수 있는가			
구체적인 성과			
병력 청취	기억력 저하의 정도 파악	발생 시기 및 경과: 서서히(알츠하이머) vs 갑자기/계단식 악화(혈관성 치매) 일상생활 지장 여부(ADL): 경도 인지장애 vs 치매 지남력 저하: 시간, 장소, 사람에 대한 인지 상태	
	기억력 저하의 원인 감별	동반 증상을 통해 원인 질환 감별하기 : 심혈관계 위험인자, 환시, 성격 변화, 보행장애, 우울, 약물력, 추위불내성 등	
신체 진찰	기본적인 인지기능검사 시행	MMSE 시행 경도 인지장애 감별	
	원인질환에 따른 신경학적 진찰	보행 분석: 정상압 수두증, 루이소체 치매/파킨슨병 국소 신경학적 징후: 혈관성 치매	
	원인질환에 따른 정신상태	우울증 평가(가성치매), 성격 변화(전두측두엽 치매), 의식 및 주의력(섬망)	
진단	신경심리검사 및 인지기능평가	스크리닝 검사	MMSE
		종합 신경심리검사	인지저하 확인 시 SNSB/CREAD-K
		정신 상태 검사	Beck 우울척도 검사
	원인감별을 위한 검사 : 영상 및 혈액 검사	구조적 이상 확인	Brain CT/MRI (뇌경색, 해마 위축)
		기능적 이상 확인	Brain PET (뇌내 대사 저하 확인)
		가역적 원인 배제	TFT(갑상샘 저하증) Vti B1(코르사코프 증후군)
치료	원인별 맞춤 치료	알츠하이머 치매	Donepezil, Memantine
		혈관성 치매	항혈소판제, 위험인자 교정
		레비소체 치매	인지기능개선제, 항정신병 약물(prn)
		전두측두엽 치매	SSRI, 항정신병 약물
	가역적 원인 및 급성 조치	정상압 수두증	VP shunt 로 뇌척수액 배출
		가성치매	SSRI
		섬망	유발 원인 치료, haloperidol
		코르사코프 증후군	Thiamine
환자	환자/보호자 교육	(보호자 있는 경우) 보호자에게도 관리 원칙 및 치료 계획/목표 설명하기	

교육		
----	--	--

● 원인 질환 정리

질환	질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료	
치매	알츠하이머 0+1	뇌에 비정상 단백질 쌓임	서서히 진행, 최근일/약속 기억 못함 오래된 기억은 잘 유지	단어찾기 X 시간지남력 X	뇌 MRI, 뇌 PET 정신상태검사 신경심리검사	인지기능개선제 (donepezil, memantine) 인지재활치료, 가족교육
	경도 인지장애 4+1	기억력이 약해지지만 일상생활은 유지되는 치매 전 단계	일상생활 지장 없는 수준 (향후 알츠하이머 진행 가능)		정신상태검사 신경심리검사	규칙적 운동 약물치료는 근거부족
	혈관성 치매 1+1	뇌졸중 등 뇌혈관 손상으로 기억력과 사고력 ↓	갑작스런 병력 계단식 악화 고혈압/뇌졸중 병력 국소 신경학적 증상		뇌 CT/MRI	위험인자 조절 항혈소판제 인지기능 개선제
	전두측두엽 치매	전두/측두엽 손상되어 발생	(전두) 성격변화/충동적 (측두) 언어이해 ↓/실어증	신경학적 검사	뇌 MRI 뇌 PET	SSRI, Antipsychotics 언어치료
	레비소체 치매	뇌세포 안 단백질 덩어리 쌓여 환각/기억력장애	인지기능 기복 환시 파킨슨증후군	신경학적 검사 종종걸음 Gait, 경축	뇌 MRI 뇌 PET	인지기능개선제 antipsychotics(환시)
정신	가성치매 1+1	우울증으로 집중/기억력 떨어짐	우울, 의욕저하 , 수면장애	MMSE 시행 시 귀찮/모른다함	Beck 우울척도검사 정신상태검사	항우울제(SSRI, TCA)
	섬망	급성 뇌기능 장애로 의식/주의/기억 나빠짐	갑자기, 최근 수술/입원, 하루 중 기복 있음 인지기능 저하 동반 가능			교정 가능한 원인치료 Haloperidol
	코르사코프 증후군	만성 알코올 중독으로 vitB 결핍	만성알코올중독 최근 기억 X, 작화증			Thiamine 영양 공급
뇌	정상압 수두증	뇌척수액이 축적되어 보행장애와 기억력 저하	보행장애: 총총, 자세불안 요실금 인지기능장애		뇌 CT/MRI	뇌실복막강 셉트
내분비	갑상샘 저하증	호르몬 부족으로 대사/집중력/기억력 감소	추위불내성, 체중 증가 의욕저하, 변비		TFT	Levothyroxine
기타	약물 사용		최근 새로 약 복용 (스테로이드, 항콜린제)			약물 중단
	외상	머리 외상으로 뇌세포 손상	머리 다침			
추가	일과성 기억장애 2	일시적인 '기억회로의 과부하'	병원에 오게 된 특정 상황이 있음 똑같은 질문을 반복 다른 증상 X. 기억장애만	MRI 해마에 작은 점	뇌 MRI	휴식
	해리성 기억장애	마음이 스스로를 보호하기 위해 기억 차단	정신적 외상력 갑작스런 소실/회복 우울, 불안, 스트레스			인지치료

O	언제 갑/서 상황: 특별한 상황/사건이 있지는 않았나요? -사고/지인의 죽음/일과성 기억상실 사건 등
L	-
D	지속 😊 좋아지기도 하나요? (좋아졌다 나빠졌다 하나요?) -r/o 루이소체 치매
Co	점점 심해지는지
Ex	이전 경험 - 치료
C	개방형 “어떤 걸 기억력이 떨어진 것이라고 말씀하시는 건가요?” [양상] 최근일(AzD)/옛날일: 아침밥/어디서태어남/약속기억 [정도] 돈 가스 단 길 일상생활 지장 -> 가스불/현관문 깜빡? 언어) 단어 안떠오름/ 상대 말 이해못함 계산) 돈 계산/관리 공간) 길 잃기
A	개방형: “다른 불편한 곳은 없으세요? 네. 그럼 제가 몇가지 자세하게 확인해보겠습니다.” 전신)발열/오한/체중변화/피로 혈관치매) 두통/시아/말어눌/팔다리 힘빠짐 전측두엽치매) 성격변화 루이소체치매) 환시/파킨슨 증상 파킨슨) 양손떨림/행동 느려짐/보행시 상체숙임/보폭감소 -걸는데 이전보다 불편하거나 달라진건 없으세요? 수두증) 요실금 감상선기능저하)추위불내성/변비 가성치매) 우울/불안 (우울/의욕감소/불안/초조/식욕변화/수면장애/죄책감/자살사고)
F	개방형: “증상이 어떨 때 좀 괜찮아지고/심해지나요?” 스트레스
E	건강검진
외	외상 - 머리 다친 적 수술 - 최근 수술 -r/o 섬망
과	기저질환 (HTN/DL/DM/Tb/Hep) -혈관치매 정신과 진료 -r/o 가성치매 뇌수막염/뇌염
약	복용 중인 약물 정신과 약 스테로이드 -r/o 가성치매
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스/식습관/운동 음주 - 과음 최종 학력 물어보기
가	비슷한 증상 치매/기억장애 뇌혈관질환
여	LMP/규칙적/폐경

시간 (+1)	5	년도/월/일/요일/계절	
장소	5	국가/시/뭐하는곳/장소이름/층	
기억등록	3	비행기/연필/소나무 환자가 바로 한번에 3 개 말하도록	
100-7 (+2)	5	36925	

기억회상	3	비행기/연필/소나무	[MMSE-K] · 지남력-시간: 연도, 월, 일, 요일, 계절 (각 1점, 총 5점) · 지남력-장소: 나라, 시도, 무엇하는 곳, 현재 장소명, 몇층 (각 1점, 총 5점) · 기억등록: "끝까지 듣고 따라해보세요" 비행기→연필→소나무 (각 1점, 총 3점) · 주의집중 및 계산: 100-7, -7, -7, -7 (각 1점, 총 5점) · 기억회상: "아까 말씀드린 3단어 기억하세요?" 비행기→연필→소나무 (각 1점, 총 3점) · 이름대기: 시계, 볼펜 (각 1점, 총 2점) · 명령시행: 종이를 뒤집어 → 반으로 접은 다음 → 저에게 주세요 (각 1점, 총 3점) · 따라말하기: "백문이 불여일견" (1점) · 읽기: '눈을 감으세요' 종이를 보고 그대로 하는지 본다 (1점) · 쓰기: "오늘 날씨가 어떻죠? 답을 종이에 써주세요." (1점) · 오각형 두 개 겹친 그림 따라 그리기 (1점) 총점 30점이며, 24점 이상일 경우 정상으로 본다.
물건이름 (+1) 읽고행동	2	볼 펜/종이	
	1	눈을 감으시오	
최종학력 확인 – 대졸이상(만점 아니면 치매배제 X), 무학/초등(경도인지장애 수준도 정상 가능) 혈관치매, 전측두 치매는 MMSE 가 상대적으로 높을 수 있음			
[20~24]: 정상 [16~19]: 경도인지장애= 치매 가능성 의심 [15 미만]: 치매가능성 높음		[24~30]: 정상 [20~23]: 경도인지장애= 치매 가능성 의심 [19-10]: 중등도 치매 [0-9]: 중증 치매	

신체진찰 (생략, 축소할게 딱히 없는 듯 합니다..)	
기본	V/S -눈-입-목(경동맥 청진)-사지-다리
	(침대에 걸터앉히고)
뇌신경	1 동공반사 2 안구운동검사- 좀 천천히 8 방향 3 감각 검사: 눈 감고 검사!! □ 2 가지(휴지+해머) – 느껴지시나요+동일한가요 4 운동검사 : 눈 꼭 감아보세요 -> 눈 벌러지나 만져보기 이 꼭 깨물어보세요 -> 턱근육 만져보기 +- 불뽕뽕/아 해보세요/ 이마 주름 만들어보세요
상하지	사지 감각, 운동, DTR → r/o 혈관치매 – 어느정도로 할지 같이 정하기 탁자위에 올리고 떨림 + rigidity r/o 레비소체/PD
보행	걸어갔다고세요 (보조해주며) r/o 혈관/레비소체/PD/정상압

시작: 걱정되는 부분? / 마지막: 이해안되거나 궁금?

진단 치료 교육	기본		영상검사 뇌 CT, PET-CT, 혈액검사(갑상선) 신경심리검사	인지기능 개선 약물
		혈관성	MRI MRA	뇌졸중 재발 방지 : 기저질환/항혈소판/항응고 이상행동-> 항정신성 약물
		섬망	-	<기저질환치료!!>+ 사진/시계/달력+ 친근한 사람 간병+적절자극
		코르사코프	-	비타민 B 보충
		가성치매	우울척도검사, 정신상태검사, 신경심리검사	우울증 약물, 상담 치료시 기억력 호전
		정상압수두증	MRI	뇌척수액 빼서 증상 나아지면 진단 가능, 배로 빼주는길 만들어주면 좋아질 것
	(안심/진단검사/치료응급/회피교정/검진접종) [안심] (경도인지장애) 알츠하이머 치매로 진행 가능, 치료 빨리 시작할수록 좋다			

	[진단검사치료] -의심되는 질환 설명- 검사: 영상검사 통해 치매관련된 뇌 기능 이상, 막힌 곳 확인, 혈액검사 통해 갑상선수치 확인 치료: 인지기능 개선약물 “치매 가능성 낮으니 너무 걱정 나~” “당분간 충분한 휴식” [응급] 혈관성 치매 : (응급) 머리가 너무 아프거나, 의식 떨어지고, 마비, 힘빠짐 증상 시 내원 [회피/교정] (보호자 있다면 보호자에게 아래에 대해 신경써달라고 하기) 기억력을 보존하는 가장 좋은 방법은, 계속해서 뇌에 긍정적 자극을 주는 것입니다. 취미만들기 : 책을 읽거나 규칙적으로 운동을 하는 등 본인이 즐길 수 있는 취미 사람만나기 : 사람은 혼자 있으면 우울해지고 마음에 병이 생기기 쉬움 메모 습관 + 규칙적 생활(정해진 일과 주고 까먹지 않게) [만성질환 관리] 약 잘드세요 사 - 술/담/운동/식사 과 - 고혈압/당뇨/심장병/고지혈증관리 – 특히 혈관성 치매 보호자 있다 : [보호자 격려] (공감) 환자 본인도 힘들지만, 보호자분도 많이 힘드시거 압니다. (주의할 점) 보호자분께서 스트레스 많이 받거나, 몸이 망가지시는 일이 없도록 (해결책) 같이 돌볼 가족이 있으면 역할을 분담 치매지원센터있고, 검사+치료비 지원+기타 활동 지원사업 있으니 연계 (돌보기 어려우면) 사회복지사 방문 치료도 가능 – 연계해 드려요? 보호자 없다 : [지원사업 교육] 치매지원센터 있고, 검사+치료비 지원+기타 활동 지원사업 있으니 연계 사회복지사 방문 치료도 가능 – 연계해 드려요? [검진/접종]
PPI	궁금하신 점 있으실까요?

- cf) [주요 우울장애] 5 가지 매일 2 주
- ①

종일우울 / 흥미저하
- ②

먹고/잠자는 문제 / 피로
- ③

불안,멍해짐 / 집중력저하,건망증
- ④

과한죄책감 / 자살생각,시도,계획